

ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობის უზრუნველყოფა პირველადი ჯანდაცვის განვითარების გზით

თამარ ჩალაძე
სტუ-ს დოქტორანტი

რევაზ შენგელია
სტუ-ს პროფესორი

რეზიუმე

პირველადი ჯანდაცვა ჯანდაცვის სისტემის საფუძველია, რომელიც უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის ხელშეწყობას, პრევენციას და სერვისების ეფექტიან გამოყენებას. კვლევები ადასტურებს, რომ ძლიერი პირველადი ჯანდაცვა ამცირებს ხარჯებს, აუმჯობესებს მოსახლეობის ჯანმრთელობას, ზრდის პაციენტთა კმაყოფილებას და ამცირებს არასაჭირო ჰოსპიტალიზაციას. მიუხედავად გლობალური შეთანხმებებისა (ალმა-ატა, 1978; ასტანა, 2018), საქართველოში პირველადი ჯანდაცვა სრულფასოვნად ვერ ფუნქციონირებს.

რეფორმები დაიწყო 1995 წლიდან, თუმცა ევროპასთან შედარებით, სერვისებზე მიმართვიანობა დაბალია. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ გაზარდა ხელმისაწვდომობა, მაგრამ ჯიბიდან გადახდების წილი კვლავ მაღალია. 2025 წლიდან პილოტირების ეტაპზე ასაკზე დაფუძნებული კაპიტაციისა და შედეგებზე ორიენტირებული დაფინანსების მოდელი, რომელიც მიზნად ისახავს ხელმისაწვდომობის, ხარისხისა და სისტემის მდგრადობის გაუმჯობესებას.

ადეკვატური დაფინანსებისა და ადამიანზე ორიენტირებული მიდგომის პირობებში, პირველადი ჯანდაცვა შეიძლება იქცეს უნივერსალური ჯანდაცვის მიღწევის ყველაზე ეფექტიან გზად და ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვან ფაქტორად.

საკვანძო სიტყვები: პირველადი ჯანდაცვის განვითარება, სახელმწიფო დაფინანსება, ჯანდაცვის ხარჯები, უნივერსალური ჯანდაცვის მიღწევა, ასაკ-სპეციფიური კაპიტაციის მეთოდი.

ENSURING THE SUSTAINABILITY OF THE HEALTHCARE SYSTEM THROUGH THE DEVELOPMENT OF PRIMARY HEALTH CARE

Tamar Chaladze
PhD student of GTU
Revaz Shengelia,
Professor of GTU

RESUME

Primary healthcare is the foundation of the health system, ensuring health promotion, disease prevention, and efficient service delivery. Research shows that

strong primary care reduces costs, improves population health, increases patient satisfaction, and decreases unnecessary hospitalizations. Despite global agreements (Alma-Ata, 1978; Astana, 2018), primary healthcare in Georgia is not yet fully functional. Reforms have been ongoing since 1995; however, compared to European countries, utilization of primary care services remains low. The Universal Health Coverage (UHC) program has improved access, yet out-of-pocket payments still account for a significant share of total health expenditures. From 2025, a pilot model based on age-adjusted capitation and performance-oriented financing will be implemented to enhance accessibility, quality, and system sustainability.

With adequate financing and a people-centered approach, primary healthcare can become the most effective path to achieving universal health coverage and a key driver of national economic development.

Key words: Primary healthcare development, Government funding, Healthcare expenditures, Achieving universal health coverage, age-adjusted capitation.

ძირითადი ტექსტი

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერება და უნივერსალური ჯანდაცვის დაფარვის მიღწევა ორივე გლობალური ჯანდაცვის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. პირველადი ჯანდაცვა მოიცავს ჯანმრთელობის ხელშეწყობას, დაავადებათა პრევენციას, ჯანმრთელობის შენარჩუნებას, განათლებას და რეაბილიტაციას. მსოფლიო ბანკი, ბილ და მელინდა გეიტსების ფონდი და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (WHO) პოლიტიკის შემქმნელებისთვის პირველად ჯანდაცვას „შავ ყუთს“ უწოდებენ -რთულს, იდუმალს და ძნელად გასაგებს.

უნივერსალური ჯანდაცვის მისაღწევად, რეფორმები უნდა იყოს ფოკუსირებული პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერებაზე. ისტორიულად ძლიერი პირველადი ჯანდაცვის მქონე ქვეყნებში ერთი ექიმის ოჯახური პრაქტიკა გადავიდა მულტიდისციპლინური გუნდების მოდელზე. სტარფილდის 1994 წლის ისტორიულმა პუბლიკაციამ, დაადასტურა, რომ ძლიერი პირველადი ჯანდაცვით სისტემებს აქვთ უფრო დაბალი ჯანდაცვის ხარჯები, მოსა-

ხლეობის უკეთესი ჯანმრთელობა, პაციენტთა უფრო მაღალი კმაყოფილება, ნაკლები არასასაქონლო ჰოსპიტალიზაცია და უფრო მეტი სოციალურ-ეკონომიკური თანასწორობა. (Weel CHW, 2018)

პირველადი ჯანდაცვის სისტემა გლობალურ პრიორიტეტად 1978 წლის ალმა-ატას დეკლარაციაში იქნა აღიარებული. პირველადი ჯანდაცვის შესახებ 2018 წლის ასტანას დეკლარაციაში მსგავსი მონოდება გაკეთდა ძირითადი ჯანდაცვის უნივერსალური დაფარვის შესახებ მთელი სიცოცხლის ციკლის განმავლობაში. თუმცა, დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნების უმეტესობაში პირველადი ჯანდაცვის სისტემა ამ დეკლარაციების დაპირებებს ვერ ასრულებს.

პირველადი ჯანდაცვის სახელმწიფო დაფინანსება არასაკმარისია, პირველადი ჯანდაცვის სერვისებზე წვდომა კვლავ არათანაბარი რჩება და პაციენტებს ხშირად მათი გამოყენებისთვის საკუთარი ჯიბიდან გადახდა უწევთ. ამიტომ, ბევრი ადამიანი გვერდს უვლის პირველადი ჯანდაცვის დანესებულებებს, რათა უფრო მაღალი დონის სპეციალიზებული მომსახურება მიიღოს. ეს ქმედება პირველად ჯანდაცვის სისტემას დაფინანსებას ართმევს, ხოლო რესურსების ნაკლებობა კიდევ უფრო ამძაფრებს პრობლემას. სწორი დაფინანსების მექანიზმების შექმნა ადამიანზე ორიენტირებული პირველადი ჯანდაცვის განვითარების მხარდაჭერის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გზაა. (Hanson K, 2022)

Lancet-ის გლობალური ჯანდაცვის კომისია ამტკიცებს, რომ ყველა ქვეყანამ უნდა ჩადოს როგორც მეტი, ასევე უკეთესი ინვესტიცია პირველად ჯანდაცვაში დამატებითი გაერთიანებული სახელმწიფო დაფინანსების მობილიზებით, პირველადი ჯანდაცვისთვის საკმარისი თანხების გამოყოფითა და პროვაიდერების ნახალისებით-(Jungo KT, 2020)

მსოფლიოს მოსახლეობის სულ მცირე ნახევარი ჯერ კიდევ არ არის სრულად უზრუნველყოფილი აუცილებელი ჯანდაცვის მომსახურებით. დაახლოებით 100 მილიონი ადამიანი კვლავ უკიდურეს სიღარიბეში იმყოფება. 800 მილიონზე მეტი ადამიანი (მსოფლიოს მოსახლეობის თითქმის 12%) ოჯახის ბიუჯეტის სულ მცირე 10%-ს ჯანდაცვისთვის ხარჯავს. გაეროს ყველა წევრი სახელმწიფო დათანხმდა, რომ მდგრადი განვითარების მიზნების ფარგლებში 2030 წლისთვის უნივერსალური ჯანდაცვის დაფარვის მიღწევას შეეცდებოდა.

უნივერსალური ჯანდაცვის სისტემა ხაზს უსვამს არა მხოლოდ იმას, თუ რა სერვისებია დაფარული, არამედ იმასაც, თუ როგორ ხდება მათი დაფინანსება, მართვა და მიწოდება. საჭიროა მომსახურების მიწოდების ფუნდამენტური ცვლილება ისე, რომ სერვისები იყოს ინტეგრირებული და ორიენტირებული ადამიანებისა და თემების საჭიროე-

ბებზე. (Munyua AG, 2024)

2019 წელს ვანდე მაელმა და სხვებმა გააანალიზეს 36 დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყანა ბოლო წლების მონაცემების მიხედვით და დაადგინეს, რომ პირველადი ჯანდაცვის ხარჯები მერყეობდა 15-დან 60 დოლარამდე ერთ სულ მოსახლეზე, რაც წარმოადგენს ჯანდაცვის მიმდინარე ხარჯების 31%-88%-ს (Maele NV, 2019)

ეკონომიკური თვალსაზრისით, პირველადი ჯანდაცვის სერვისებს შეუძლიათ თავიდან აიცილონ მეორადი ჯანდაცვის ინტენსიური სერვისების საჭიროება და ხელი შეუწყონ ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას, რამაც შეიძლება გაზარდოს ადამიანების პროდუქტიულობა და ეკონომიკური შედეგები. (Clarke L, 2021)

გადახდის მექანიზმები, უნდა იყოს ადამიანზე ორიენტირებული. ჯიბიდან გადახდები უნდა შემცირდეს იმ დონემდე, რომ ისინი აღარ წარმოადგენდნენ ფინანსურ ბარიერს საჭირო სამედიცინო მომსახურებისადმი წვდომაზე. დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნების უმეტესობაში პირველადი ჯანდაცვისთვის სახელმწიფო დაფინანსების ამ დონის გენერირება შესაძლებელია მხოლოდ ზოგადი საგადასახადო შემოსავლებიდან პირველადი ჯანდაცვისთვის გამოყოფილი თანხების გაზრდის გზით და შესაბამისად, მოითხოვს ქვეყნების დაბეგვრის შესაძლებლობების გაფართოებას. მხოლოდ პირველადი ჯანდაცვის უნივერსალური დაფარვის მიღწევის შემდეგ უნდა გაფართოვდეს გაერთიანებული რესურსები სხვა საჭიროების დასაფარად.. (Stenberg k, 2019)

საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა 1995 წლიდან დაიწყო, თუმცა ჩატარებული კვლევები ადასტურებს, რომ სისტემა ვერ განვითარდა იმ სტანდარტებით, რომლებიც უკვე ათწლეულებია არსებობს ევროპის ბევრ ქვეყანაში. საქართველოში 2024 წელს ერთ სულ მოსახლეზე ამბულატორიულ სამედიცინო დანესებულებაში მიმართვიანობა საშუალოდ 4.3-ია, მაშინ როდესაც ევროპაში – 7.5-მდე აღწევს. პირველადი ჯანდაცვის სისტემის არასაკმარისი განვითარება მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენას ახდენს ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტატუსზე, შრომისუნარიანობასა და ეკონომიკურ აქტივობაში მონაწილეობის შესაძლებლობებზე. აღნიშნული მდგომარეობა განიხილება როგორც საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დანაკარგი, რომელიც პირდაპირ გარდაიქმნება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ზარალად.

2000 წლიდან საქართველოში დაიწყო პირველადი ჯანდაცვის (პჯ) სისტემის გაძლიერება. საწყის ეტაპზე მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენდა პჯ სტრუქტურის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება. რეფორმები ეფუძნებოდა შერეულ მოდელს,

რომელიც ითვალისწინებდა ეროვნული და რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრების გაძლიერებას. 2007 წელს განხორციელდა ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმა, რომელიც მიზნად ისახავდა ჯანდაცვის სერვისების ფინანსური ხელმისაწვდომობის ზრდას მოსახლეობისთვის. რეფორმამ მოიცვა ამბულატორიული მომსახურების დაფინანსების სისტემა, სადაც განისაზღვრა ფინანსური პაკეტი ოჯახის ექიმისა და სპეციალისტების ვიზიტებისთვის, ასევე სადიაგნოსტიკო და ლაბორატორიული ანალიზების ლიმიტები ოჯახის ექიმის დანიშნულებით. 2012 წელს განხორციელდა სახელმწიფო პროგრამა, რომელმაც მოიცვა 1 635 217 ბენეფიციარი, რაც მოსახლეობის დაახლოებით 36%-ს შეადგენდა. მათგან 535 662 პირმა (11%) მიიღო მომსახურება ინდივიდუალურად ან კორპორატიულ კონტრაქტებზე დაფუძნებული სქემებით. 2011 წელს საშუალო ამბულატორიული ვიზიტების რაოდენობა ერთ პაციენტზე წელიწადში 2.1-ს შეადგენდა. 2013 წლიდან საქართველოში ამოქმედდა სახელმწიფო პროგრამა პირველადი ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ზრდისთვის, რომლის ძირითადი მიზანი იყო მოსახლეობისთვის ჯანდაცვის სერვისების ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 2014 წელს ამბულატორიული მომსახურებით დაახლოებით 25% პაციენტმა ისარგებლა, რაც ფინანსური ხელმისაწვდომობის ზრდის მნიშვნელოვან მაჩვენებლად ითვლებოდა. თუმცა, მხოლოდ 22%-მა მიიღო ამბულატორიული ექიმის რეალური სამედიცინო მომსახურება. (ვერულავა თ, პირველადი ჯანდაცვის სისტემა და მისი როლი ჯანმრთელობის კაპიტალის ამაღლებაში, 2021)

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის დანერგვამ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობა და მოხმარება. ამბულატორიული სერვისების საშუალო რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე გაიზარდა 2,1 ვიზიტიდან 2012 წელს 4,0 ვიზიტამდე. 2019 წელს. მსოფლიო ბანკის, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და გლობალური ფონდის მიერ 2017 წელს ჩატარებული კვლევის (HUES-ის კვლევა) შედეგებით, მოსახლეობის ჯანდაცვის მომსახურების გამოყენება

2010-2017 წლებში მკვეთრად გაიზარდა: 2010 წელს –მოსახლეობის 75%-მა მიმართა ჯანდაცვის პროვაიდერებს, 2014 წელს – 79%-მა, ხოლო 2017 წელს – 82%-მა. ეს მაჩვენებლები ადასტურებს პირველადი ჯანდაცვის სერვისების უფრო ფართო გამოყენებას და ხელმისაწვდომობის ზრდას ქვეყნის მასშტაბით.თუმცა, ბოლო წლებში მოსახლეობის საკუთარი ჯიბიდან გადახდები ჯანდაცვისთვის მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2013-2018 წლებში ჯანდაცვის ხარჯების წილი გაიზარდა 11.5%-დან 17.4%-მდე, რაც განსაკუთრებით მძიმე ტვირთად აწევბა უღარიბეს შემოსავლიან მოსახლეობას. (ვერულავა თ, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა:პრობლემები და გადაწყვეტის გზები, 2024)

გეგმური ამბულატორიული მომსახურებისათვის პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების დაფინანსება ხორციელდება კაპიტაციური მეთოდით.

2025 წლის 1 ივლისიდან, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების ფარგლებში, დაიწყო დაფინანსების განახლებული მოდელის ასაკ-სპეციფიკური კაპიტაციის პილოტირება.

დაფინანსების განახლებული მოდელის ფარგლებში, ბაზისური კაპიტაციის გაზრდილი მოცულობა განისაზღვრა 4.20 ლარით (ნაცვლად 1,93 ლარისა), ხოლო დამატებითი კაპიტაციის გაზრდილი მოცულობა – 2.20 ლარით(ნაცვლად 1,07 ლარისა). მოსახლეობის სამედიცინო საჭიროებების უკეთ გათვალისწინების მიზნით, კაპიტაციის ერთიანი (უნიფიცირებული) მოდელი იცვლება ასაკ-სპეციფიკური ტარიფებით, რომლებიც განსაზღვრულია შემდეგი ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით: (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 2025) (იხ. ცხრილი)

2026 წლის იანვრიდან იენისის ჩათვლით, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი ყველა დაწესებულება ვალდებული იქნება უზრუნველყოს მოსარგებლეთა ხელახალი რეგისტრაცია. რეგისტრაციის პროცესი განხორციელდება გეოგრაფიული პრინციპის დაცვით, მოსახლეობის ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართის

ასაკობრივი ჯგუფი	ბაზისური კაპიტაციის მოცულობა	ოჯახის/უბნის ექიმის/ექტნის მომსახურების ღირებულება	დამატებითი კაპიტაციის მოცულობა
0-5 წელი	7.11 ლარი	5.46 ლარი	1.65 ლარი
6-18 წელი	2.11 ლარი	1.32 ლარი	0.79 ლარი
19-40 წელი	1.71 ლარი	0.74 ლარი	0.97 ლარი
41-65 წელი	4.11 ლარი	1.60 ლარი	2.51 ლარი
65+ წელი	8.45 ლარი	3.68 ლარი	4.77 ლარი
ჯამური კაპიტაცია	4.20 ლარი	2.00 ლარი	2.20 ლარი

გათვალისწინებას. აღნიშნული ცვლილება მიზნად ისახავს პირველადი ჯანდაცვის სერვისების უკეთესად დაგეგმვასა და რესურსების გონივრულ განაწილებას, ასევე მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებაზე წვდომის გაუმჯობესებას. დაფინანსების განახლებული მოდელის დანერგვისთვის სამედიცინო დაწესებულებები ვალდებული არიან დააკმაყოფილონ გარკვეული კრიტერიუმები. მათ შორისაა გეგმური ამბულატორიული მომსახურების გაფართოებული პაკეტის მიწოდება, შესაბამისი სამედიცინო აპარატურით აღჭურვა, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრალური სამედიცინო ჩანაწერების სისტემაში (C-EMR) შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება.

დღესდღეობით საქართველოში მეორადი სერვისების გამოყენება უფრო აქტუალურია, ამიტომ აუცილებელია პირველადი ჯანდაცვის გაუმჯობესება უნივერსალური ჯანდაცვის მისაღებად. მისი განვითარების გარეშე შეუძლებელია მდგრადი და თანასწორი ჯანდაცვის უზრუნველყოფა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კომპონენტია პრევენცია, რომელიც არა მხოლოდ დაავადებების თავიდან აცილებას ემსახურება, არამედ მთლიანობაში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს. პრევენციული ღონისძიებები, როგორიცაა ვაქცინაცია, სკრინინგი, ჯანმრთელი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, ქრონიკული დაავადებების პრევენცია და ჯანმრთელობის განათლება, ქმნის მყარ საფუძველს ჯანდაცვის სისტემის ეფექტიანობისთვის. ამასთან, მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება და ინფორმირებულობის გაზრდა წარმოადგენს გადამწყვეტ ფაქტორს, რათა მოქალაქეებმა თავადაც აიღონ პასუხისმგებლობა საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვაზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ვერულავა თ. (2021). პირველადი ჯანდაცვის სისტემა და მისი როლი ჯანმრთელობის კაპიტალის ამაღლებაში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
2. ვერულავა თ. (2024). სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა: პრობლემები და გადამწყვეტის გზები. ორბელიანი.

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შ. ჯ. (2025, 04 30). www.matsne.gov.ge. Retrieved from საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე.

4. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს მთავრობის დადგენილება #36, 2013 წლის 21 თებერვალი.

5. Clarke L, A. M. (2021). Economic Aspects of Delivering Primary Care Services: An Evidence Synthesis to Inform Policy and Research Priorities. THEMIL-BANKQUARTERLY.

6. Hanson K, B. N. (2022). The Lancet Global Health Commission on financing primary health care: putting people at the centre. The Lancet Global Health Commissions, [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00005-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00005-5).

7. Jungo KT, A. D. (2020). Astana declaration: a new pathway for primary health care. Swiss School of Public Health, <https://doi.org/10.1007/s00038-020-01368-5>.

8. Maele NV, X. K. (2019). Measuring primary health-care expenditure in low-income and lower middle-income countries. BMJ Journals.

9. Munyua AG, S. S. (2024). Reducing fragmentation of primary healthcare financing for more equitable, people-centred primary healthcare. BMJ Global Health.

10. Stenberg k, H. O. (2019). Guide posts for investment in primary health care and projected resource needs in 67 low-income and middle-income countries: a modelling study. www.thelancet.com.

11. Weel CHW, M. R. (2018). Why strengthening primary health care is essential to achieving universal health coverage. Canadian Medical Association Journal, <https://doi.org/10.1503/cmaj.170784>.

12. World Health Organization . Universal health coverage primary health care towards universal health coverage. WHA 72/12. 2019. https://apps.who.int/gb/e/e_wha72.html. Accessed April 12, 2021.

13. Assembly United Nations General. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development UNGA A/RES/70/1. 2015. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E. Accessed April 12, 2021.